

Problema 2. Decisión de salud pública sobre el control del OxyContin

Enunciado

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, diversas agencias de salud pública se enfrentaron a la introducción y fuerte promoción comercial de nuevos analgésicos opioides, como el OxyContin. Para este problema basado en una situación real, nos situamos en la posición de un comité de un servicio regional de salud que debe establecer el protocolo oficial para la prescripción de este potente medicamento.

El comité busca maximizar el “beneficio social neto”, una métrica que suma los beneficios derivados del alivio efectivo del dolor en la población y resta los graves costes sanitarios, sociales y económicos derivados de la adicción, sobredosis y desvío al mercado negro.

El comité valora cuatro alternativas (protocolos):

- **A1. Prescripción generalizada (Laxa):** Permitir a cualquier médico recetar el fármaco para dolores moderados y crónicos no oncológicos, tal y como sugería la campaña de la farmacéutica.
- **A2. Uso estrictamente oncológico:** Restringir la prescripción exclusivamente a pacientes con cáncer terminal o dolor agudo postoperatorio severo en entorno hospitalario.
- **A3. Prescripción con control estricto:** Permitir el uso para dolor crónico, pero exigiendo derivación a Unidades del Dolor, contratos terapéuticos, test de drogas regulares y seguimiento exhaustivo.
- **A4. Restricción total / Sustitución:** Prohibir su inclusión en el vademécum regional, obligando a usar alternativas no opioides o analgésicos tradicionales menos potentes.

El impacto final depende fundamentalmente de la respuesta poblacional y del potencial adictivo real del fármaco a largo plazo (estado de la naturaleza):

- **Q1. Baja tasa de adicción:** El medicamento se usa mayoritariamente según lo prescrito y los casos de abuso son anecdóticos.
- **Q2. Adicción moderada:** Existe un desvío moderado al mercado negro y una parte de los pacientes desarrolla dependencia que requiere tratamiento.
- **Q3. Adicción severa:** Se desata una crisis epidémica de opioides con altos índices de mortalidad, crimen y colapso de los servicios de urgencias.

La estimación del beneficio social neto (expresado en millones de euros, donde los valores negativos representan un desastre social y económico) es la siguiente:

```
tabla_oxy <- matrix(
  c( 50, 10, -80,
      20, 20, 15,
      35, 25, -10,
      10, 10, 10),
  nrow = 4,
  byrow = TRUE
)

rownames(tabla_oxy) <- c(
  "A1. Prescripción generalizada",
  "A2. Uso estrictamente oncológico",
  "A3. Control estricto",
  "A4. Restricción total"
)

colnames(tabla_oxy) <- c(
  "Q1. Baja adicción",
  "Q2. Adicción moderada",
```

```
"Q3. Adicción severa"
)
```

```
tabla_oxy
```

##	Q1. Baja adicción	Q2. Adicción moderada
## A1. Prescripción generalizada	50	10
## A2. Uso estrictamente oncológico	20	20
## A3. Control estricto	35	25
## A4. Restricción total	10	10
##	Q3. Adicción severa	
## A1. Prescripción generalizada	-80	
## A2. Uso estrictamente oncológico	15	
## A3. Control estricto	-10	
## A4. Restricción total	10	